

Fístula rectouretral (en hombres)

WARWIKI

Información para el paciente · Una conexión anormal entre el recto y el conducto de la orina

Una fístula rectouretral es una conexión anormal (un pequeño túnel) entre el **recto** (conducto posterior) y la **uretra** (conducto de la orina). Puede dejar que la orina pase al recto y que el gas o las heces pasen a la orina, con infecciones repetidas. Es angustiante, pero se puede reparar — por lo general con un enfoque planificado y por etapas.

Acerca de esta afección

Los síntomas suelen incluir **gas o heces en la orina** (burbujas al orinar, orina turbia o con mal olor), **escape de orina por el recto**, infecciones urinarias recurrentes y molestia pélvica. Es un problema de plomería con una solución de plomería — no es reflejo de nada que usted haya hecho.

Qué la causa

La mayoría de las fístulas rectouretrales son una **complicación del tratamiento del cáncer de próstata** — cirugía (prostatectomía), **radiación** o ablación (como la crioterapia o el HIFU) — o aparecen después de una cirugía del recto. Con menos frecuencia se deben a una lesión, una infección o una enfermedad inflamatoria intestinal. Las fístulas que siguen a la **radiación** son más complejas de sanar.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Fístula

Un túnel anormal que conecta dos órganos.

Rectouretral

Entre el recto y la uretra.

Neumatúria

Gas/burbujas que salen en la orina.

Fecaluria

Material de las heces en la orina.

Derivación

Desviar temporalmente la orina y/o las heces para permitir la sanación.

Colostomía

Una abertura temporal para las heces que puede usarse y luego revertirse.

Colgajo de gracilis

Un colgajo de músculo del muslo que a menudo se usa para reforzar la reparación.

¿POR QUÉ PODRÍA NECESITAR PRIMERO UN ESTOMA O UNA SONTA TEMPORAL? Desviar la orina (una sonda o un tubo) y a veces las heces (una colostomía temporal) quita presión de la zona, controla la infección y permite que el tejido inflamado se calme — lo que le da a la reparación posterior la mejor oportunidad de sanar. Las derivaciones suelen ser **temporales** y se revierten después de la sanación.

Cómo se diagnostica

- Una mirada dentro de la vejiga/uretra (**cistoscopia**) y del recto
- **Pruebas con tinte** e imágenes para ubicar el tamaño y la ubicación de la fístula
- Revisión de sus antecedentes (tratamiento de próstata, radiación) y de la calidad del tejido

Cómo se trata

- 1 **Calmar y derivar** — una sonda (y a veces una colostomía temporal) para controlar los síntomas y permitir que el tejido se recupere.
- 2 **Reparación quirúrgica** — comúnmente a través de la zona entre el escroto y el ano (transperineal), cerrando la conexión por capas.
- 3 **Colgajo de tejido** — se coloca músculo sano (a menudo un **colgajo de gracilis** del muslo) entre las reparaciones, especialmente después de la radiación.
- 4 **Reversión** — los estomas temporales se revierten más adelante, una vez que se confirma la sanación.

Bueno saber

- El momento importa — los cirujanos a menudo esperan a que la inflamación se calme antes de reparar.
- Las fístulas pequeñas y sin radiación a veces se cierran solo con una sonda.
- Una buena nutrición y no fumar ayudan a la sanación.

Busque atención si tiene:

- **Fiebre, escalofríos o sensación de estar muy mal** (posible infección grave)
- Dolor pélvico o rectal intenso
- **No puede orinar** o sangrado abundante

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Una fístula rectouretral conecta el recto y la uretra — causando gas/heces en la orina e infecciones — con mayor frecuencia después del tratamiento del cáncer de próstata.
2. La atención suele ser por etapas: primero derivar y calmar, luego reparar (a menudo con un colgajo de tejido, especialmente después de la radiación) y luego revertir los estomas temporales.
3. Se puede reparar. Busque atención con urgencia si tiene fiebre, dolor intenso o incapacidad para orinar.